

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE
HUAMANGA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SALUD
“ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON ENFOQUE
INTERCULTURAL Y CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA POR
LOS USUARIOS, AYACUCHO 2026”

INVESTIGADORA PRINCIPAL:

Gresly Lucero Pariona Palomino

Cátedra: Proyecto de Investigación en Salud (EN 486)

DOCENTE TITULAR / ASESOR:

Dr. Manglio Aguirre Andrade

Facultad de Ciencias de la Salud – UNSCH

AYACUCHO – PERÚ

2026

Índice

INTRODUCCIÓN	1
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	2
1.1. Contextualización del problema de investigación	2
1.2. Formulación de las preguntas norteadoras	3
1.2.1. Pregunta general	3
1.2.2. Preguntas específicas	3
1.3. Formulación de los objetivos de investigación	3
1.3.1. Objetivo general	3
1.3.2. Objetivos específicos	4
1.4. Justificación de la investigación	4
1.5. Viabilidad y consideraciones ético-operativas	5
2. MARCO CONTEXTUAL	6
2.1. Descripción geográfica del área de estudio	6
2.2. Características demográficas del área de estudio	6
2.3. Características sociales y culturales	6
2.4. Dinámica económica del área de estudio	6
2.5. Características sanitarias del área de estudio	7
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8
ANEXOS	9
Anexo 1: Guía de Entrevista Bilingüe	9
Anexo 2: Matriz de Consistencia Cualitativa	10
Anexo 3: Juicio de Expertos	11
Anexo 4: Consentimiento Informado Bilingüe	11
Anexo 5: Carta de Asesoría de Tesis	11

INTRODUCCIÓN

El acceso universal a los servicios de salud y la calidad de atención constituyen derechos humanos fundamentales y pilares insustituibles para alcanzar el bienestar colectivo y la equidad social. En el contexto de los sistemas de salud contemporáneos, la provisión de servicios sanitarios no solo demanda suficiencia de recursos materiales e infraestructura tecnológica, sino una profunda adecuación ética, interpersonal y cultural a las necesidades y vivencias cotidianas de la población usuaria.

El presente proyecto de investigación aborda el fenómeno del acceso a los servicios de salud y la calidad de atención desde la vivencia cotidiana y la subjetividad de los usuarios andinos quechuahablantes en los establecimientos públicos del primer y segundo nivel de atención de la ciudad de Ayacucho (Huamanga). Para ello, articula de forma rigurosa el modelo multidimensional de Roy Penchansky y J. William Thomas [1], ampliado por la propuesta sistémica de Jean-Frédéric Levesque et al. [2] y la teoría de evaluación de la calidad de los servicios de salud de Avedis Donabedian [3], incorporando la pertinencia cultural y lingüística exigida por las características sociodemográficas de nuestra región.

En concordancia con los lineamientos metodológicos de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la investigación adopta un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico hermenéutico. Este abordaje permite desentrañar los significados subyacentes, las percepciones sentidas y las valoraciones que los usuarios asignan a las dimensiones de disponibilidad de fármacos, accesibilidad geográfica, acomodación administrativa, asequibilidad económica y aceptabilidad cultural en su interacción con el personal asistencial.

La investigación se fundamenta y alinea estrictamente con los instrumentos rectores del sector salud: a nivel regional, responde a la Prioridad Regional 10 de la DIRESA Ayacucho 2025–2030 (“Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud”) [4]; a nivel nacional, se adscribe a la Línea 10 de Investigación del Ministerio de Salud al 2030 (“Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal”, RM N° 424-2025/MINSA) [5] y a la Norma Técnica de Salud para la Adecuación Cultural de los Servicios de Salud (NTS N° 121-MINSA/DGIESP) [6]. Metodológicamente, adopta el paradigma interpretativo con entrevistas en profundidad bilingües (quechua-español), garantizando el rigor científico mediante los criterios de credibilidad, transferibilidad, consistencia y confirmabilidad.

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Contextualización del problema de investigación

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud [7] y la Organización Panamericana de la Salud han ratificado que el acceso efectivo a la atención de salud constituye un derecho fundamental y la piedra angular del bienestar social. Sin embargo, persisten marcadas brechas en la cobertura sanitaria universal, particularmente en regiones caracterizadas por desigualdades socioeconómicas, aislamiento geográfico y diversidad etnolingüística.

En el Perú, el Ministerio de Salud [8] reporta que más del 90 % de la ciudadanía se encuentra formalmente afiliada a algún régimen de aseguramiento público (principalmente el Seguro Integral de Salud – SIS). No obstante, la afiliación nominal no se traduce automáticamente en un acceso real, oportuno y de calidad. Persisten deficiencias críticas expresadas en el desabastecimiento crónico de medicamentos e insumos de primera línea, prolongados tiempos de espera para la obtención de citas médicas y atención en consulta externa (promedios superiores a 150 minutos en sala), así como barreras burocráticas y organizacionales complejas.

En el contexto regional de Ayacucho, y particularmente en el ámbito territorial de la provincia de Huamanga, la problemática se agudiza por la convergencia de una alta demanda asistencial y la centralización de servicios especializados en el Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” y los centros de salud cabecera de la Red Huamanga (C.S. San Juan Bautista y C.S. Belén). Gran parte de los usuarios proviene de distritos rurales y comunidades andinas quechuahablantes, debiendo realizar sacrificados viajes de varias horas a pie o en vehículos de transporte rural, pernoctando en la intemperie en las afueras de los hospitales desde las 3:00 a.m. para conseguir un cupo de atención médica.

Durante el encuentro asistencial, los usuarios se enfrentan con frecuencia a un personal sanitario que se comunica exclusivamente en castellano o que utiliza terminología clínica técnica incomprensible, omitiendo la cosmovisión andina y las valoraciones tradicionales de la salud. Estas barreras comunicacionales no solo generan angustia, desconfianza y pudor en los pacientes, sino que comprometen gravemente la seguridad técnica del tratamiento y la adherencia terapéutica, consolidando una percepción de mala calidad y deshumanización del cuidado de enfermería y médico. Ante este panorama, se vuelve imperativo investigar a profundidad las vivencias de los usuarios para comprender los significados y barreras que configuran el acceso y la calidad en el contexto sanitario local.

1.2. Formulación de las preguntas norteadoras

En la investigación con enfoque cualitativo fenomenológico, el problema no se operacionaliza mediante variables cuantitativas aisladas, sino a través de interrogantes reflexivas que exploran la esencia de la vivencia humana:

1.2.1. *Pregunta general*

¿Cuáles son las vivencias y significados que atribuyen los usuarios al acceso a los servicios de salud con enfoque intercultural y a la calidad de atención percibida en los establecimientos de salud de Ayacucho, 2026?

1.2.2. *Preguntas específicas*

1. ¿Cómo experimentan los usuarios la disponibilidad de medicamentos esenciales, insumos clínicos y presencia de profesionales de salud durante su atención? (*¿Tarikunchu hampikuna hampina wasipi icha qawapichu rantinki qullqillaykiwan?*)
2. ¿Qué significados otorgan a las dificultades geográficas, distancias recorridas y costos de traslado para llegar al establecimiento de salud? (*¿Imaynatam llaqtaykimanta hamunki hampina wasiman unqusqa kaspayki?*)
3. ¿Cuáles son las vivencias asociadas al gasto de bolsillo y limitaciones económicas asumidas para costear fármacos y procedimientos no cubiertos?
4. ¿Cómo perciben los usuarios los trámites administrativos, colas de madrugada y horarios de asignación de cupos de atención? (*¿Ima sasachakuykunatam tarinki tutamanta sayaspa cupota chaskinaykipaq?*)
5. ¿De qué manera experimentan y valoran el trato humano, el respeto a su vestimenta y costumbres andinas, y la comunicación en idioma Quechua chanka por parte del equipo de salud? (*¿Ima simipim rimapayasunki hampiqkuna? ¿Allintachu intillinki hampina simipi rimapayasuptiyki?*)

1.3. Formulación de los objetivos de investigación

1.3.1. *Objetivo general*

Comprender las vivencias y significados sobre el acceso a los servicios de salud con enfoque intercultural y la calidad de atención percibida por los usuarios en los establecimientos de salud de Ayacucho, 2026.

1.3.2. *Objetivos específicos*

1. Develar las vivencias de los usuarios respecto a la disponibilidad y carencia de medicamentos esenciales, insumos y profesionales en el servicio de salud.
2. Describir los significados atribuidos a las dificultades geográficas, tiempo de viaje y barreras físicas de acceso a los establecimientos de salud.
3. Comprender la carga sentida respecto al gasto de bolsillo y sacrificios económicos asumidos por las familias para costear su atención médica.
4. Analizar las vivencias sobre la organización institucional, horarios de atención, colas de madrugada y trámites administrativos en la obtención de citas.
5. Interpretar las experiencias sobre el trato digno, la empatía, el respeto a las costumbres andinas y la pertinencia lingüística en Quechua brindada por el personal de enfermería y salud.

1.4. **Justificación de la investigación**

El presente estudio se sustenta en cuatro pilares fundamentales:

- **Justificación Teórica:** Articula de manera sinérgica los modelos clásicos y contemporáneos de Roy Penchansky y J. William Thomas [1], Jean-Frédéric Levesque et al. [2] y Avedis Donabedian [3], adaptándolos a la realidad sociocultural andina. Aporta un marco conceptual situado que integra la variable cultural como eje transversal indisociable de la calidad asistencial, superando el reduccionismo biomédico imperante.
- **Justificación Práctica y Social:** Proporciona evidencia empírica directa sobre las barreras reales, vivencias y expectativas insatisfechas de los usuarios más vulnerables de Huamanga. Sus resultados servirán de base técnica para que los comités de gestión de la DIRESA Ayacucho y las microrredes de salud diseñen estrategias de mejora continua, optimización de tiempos de espera, abastecimiento oportuno y humanización del cuidado enfermero, respaldada por la evidencia empírica regional de Aguirre-Andrade et al. [9] en Cangallo.
- **Justificación Metodológica:** Desarrolla y valida una matriz de categorización fenomenológica y una guía de entrevista en profundidad bilingüe (quechua-español), que podrán ser replicadas y adaptadas por futuras investigaciones de pregrado y posgrado en la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSCH y otras universidades del país.
- **Justificación Institucional y Sanitaria:** Responde de manera prioritaria y directa a la Línea 10 de Investigación MINSA 2030 (“Sistemas y servicios de salud, acceso y cobertura universal”, RM N° 424-2025/MINSA) [5] y a la Prioridad 10 de

la DIRESA Ayacucho 2025–2030 (“Organización, gestión, calidad y accesibilidad de los servicios de salud”) [4].

1.5. Viabilidad y consideraciones ético-operativas

El proyecto cuenta con plena viabilidad técnica, operativa y presupuestal (financiamiento íntegramente cubierto de S/. 1,850.00). En estricta salvaguarda del rigor ético, bioético y normativo-institucional, **el presente protocolo de investigación será formalmente sometido a la revisión, evaluación y dictamen de aprobación por el Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI)** de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y acreditado ante la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho, **como requisito previo, vinculante e indispensable antes de iniciar cualquier contacto empírico con pacientes, ejecución de la prueba piloto o recolección de testimonios en los establecimientos de salud**. Asimismo, el estudio se adhiere de forma irrestricta a los principios bioéticos universales consagrados en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial [10] y en las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Relacionada con la Salud con Seres Humanos elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) [11]. Se aplicará el Consentimiento Informado bilingüe (Anexo 4), garantizando la voluntariedad, anonimato mediante códigos alfanuméricos despersonalizados, confidencialidad estricta y el derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin repercusión asistencial alguna.

2. MARCO CONTEXTUAL

2.1. Descripción geográfica del área de estudio

El estudio se desarrollará en el ámbito de la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, ubicada en la sierra central y sur del Perú, sobre la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, a una altitud media de 2,761 m.s.n.m. El escenario empírico comprende los consultorios externos y áreas de espera del Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” (Nivel de Atención III-1) y los centros de salud estratégicos de primer nivel de la Microrred Huamanga (C.S. San Juan Bautista y C.S. Belén, Nivel I-4).

2.2. Características demográficas del área de estudio

La provincia de Huamanga alberga una población estimada de 281,270 habitantes según las proyecciones y estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática [12]. La estructura poblacional muestra una pirámide en transición demográfica, con predominio de población joven y en edad fértil (15 a 49 años: 54.2 %), un segmento infantil significativo (menores de 5 años: 9.8 %) y un crecimiento sostenido de adultos mayores (60 años a más: 10.5 %). El índice de feminidad refleja una ligera mayoría de mujeres (51.4 %), quienes asumen prioritariamente el rol de cuidadoras y demandantes de servicios materno-infantiles.

2.3. Características sociales y culturales

El tejido social de Ayacucho se distingue por una profunda matriz sociocultural andina. Más del 63 % de la población de Huamanga tiene al Quechua chanka como lengua materna o es bilingüe quechua-español. Las concepciones sobre la salud, el cuerpo y la enfermedad se encuentran estrechamente ligadas a la medicina tradicional andina (equilibrio térmico cálido-frío, etiologías culturales como el susto, mal de viento y cólera). Esta identidad convive cotidianamente con un sistema formal de salud que opera bajo el paradigma biomédico occidental.

2.4. Dinámica económica del área de estudio

La estructura económica regional descansa en el sector terciario (comercio minorista ambulatorio, transporte y servicios urbanos) y en la agricultura familiar de subsistencia en el entorno rural. De acuerdo con las cifras del INEI [12], el departamento de Ayacucho

registra una tasa de pobreza monetaria total superior al 40.5 %, ubicándose entre los departamentos más vulnerables del país. La informalidad laboral supera el 78 % de la Población Económicamente Activa (PEA). En materia de salud, esta precariedad se traduce en una severa limitación económica: ante recetas médicas insatisfechas en farmacia, las familias deben incurrir en un elevado “gasto de bolsillo”, debiendo vender animales menores o privarse de alimentación para costear pasajes y fármacos comerciales.

2.5. Características sanitarias del área de estudio

El perfil epidemiológico de Huamanga evidencia una doble carga de enfermedad: persisten enfermedades infecciosas y deficiencias nutricionales crónicas (anemia infantil con prevalencias de 48.5 % en menores de 36 meses y desnutrición crónica infantil), coexistiendo con el incremento progresivo de enfermedades no transmisibles y crónico-degenerativas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, neoplasias y trastornos de salud mental). La red asistencial se estructura a través de la Red de Salud Huamanga y el Hospital Regional de Ayacucho, experimentando una severa sobrecarga asistencial, déficit crónico de médicos especialistas y profesionales de enfermería, y brechas estructurales en infraestructura hospitalaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Penchansky R, Thomas JW. The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. *Med Care*. 1981;19(2):127-140. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/00005650-198102000-00001>
- [2] Levesque JF, Harris MF, Russell G. Patient-centred access to health care: conceptualising access at the interface of health systems and populations. *Int J Equity Health*. 2013;12(18):1-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-18>
- [3] Donabedian A. The quality of care: How can it be assessed? *JAMA*. 1988;260(12):1743-1748. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jama.1988.03410120089033>
- [4] Dirección Regional de Salud de Ayacucho. Prioridades Regionales de Investigación en Salud de Ayacucho 2025–2030. Ayacucho: DIRESA; 2025. Boletín Epidemiológico N° 01-2025. Disponible en: <https://www.saludayacucho.gob.pe/>
- [5] Ministerio de Salud del Perú. Líneas de Investigación en Salud al 2030: Resolución Ministerial N° 424-2025/MINSA. Lima: MINSA; 2025. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/6902922-424-2025->
- [6] Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Adecuación Cultural de los Servicios de Salud: NTS N° 121-MINSA/DGIESP. Lima: MINSA; 2016. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/191322-518-2016-minsa>
- [7] Organización Mundial de la Salud. Cobertura Sanitaria Universal: Informe de Monitoreo Global 2023. Ginebra: OMS; 2023. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240080379>
- [8] Ministerio de Salud del Perú. Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo: Resolución Ministerial N° 527-2011/MINSA. Lima: MINSA; 2011. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/243399-527-2011->
- [9] Aguirre-Andrade M, Tenorio-Acosta I, Rivas-Díaz L, Valenzuela-Oré F, Sánchez-Simbrón M, Quino-Huamaní F. Promoción de salud y nivel de salubridad de las familias, en comunidades del Distrito de Cangallo, Ayacucho 2020. *Rev Investig Salud*. 2020;14(2):45-58. Disponible en: <https://doi.org/10.35622/j.rie.2020.02.004>
- [10] Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Ferney-Voltaire: WMA; 2013. Disponible en: <https://www.wma.net/es/politicas-post/declaracion-de-helsinki>
- [11] Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS).

Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Ginebra: CIOMS; 2016. Disponible en: https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SPANISH.pdf

- [12] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023. Informe Técnico. Lima: INEI; 2024. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/nota-tecnica-evolucion-de-pdf